核心精讲

腹外疝

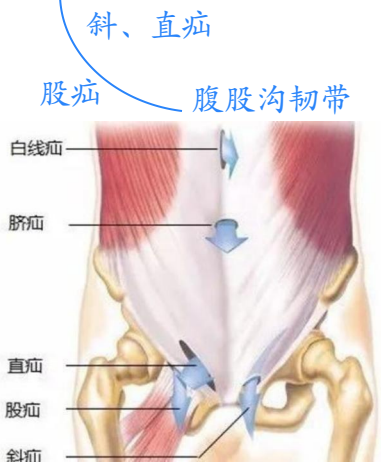
（性感认识：解剖）

内科 其他大肠与肛管疾病&腹外疝1
00:49:13-01:24:17
内科 腹外疝2
00:00:00-00:50:18

一、腹外疝概述

「理顺知识点」
- 疝：体内脏器或组织从一个地方到另一个地方

（一）发病机制



1.腹壁强度降低而成为腹壁薄弱或缺损区

（1）腹部组织先天发育不全、后天萎缩

（2）某些组织穿过腹壁

①大隐静脉穿过股管——股疝

②精索或子宫圆韧带穿过腹股沟管——腹股沟斜疝

③脐血管穿过脐环——脐疝

2.腹腔内压力增高：慢性咳嗽如 COPD、便秘、排尿困难如前列腺增生或尿路结石、腹水、妊娠、搬重物等

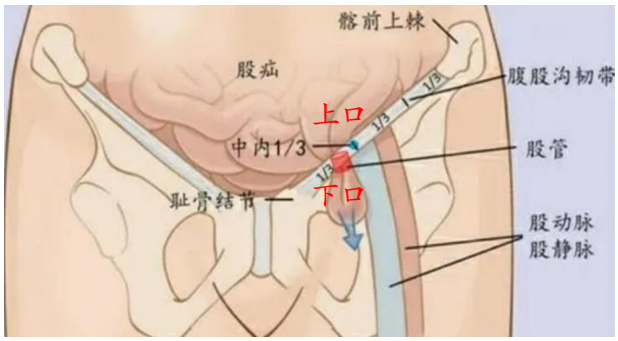
「理顺知识点」
- 腹外疝手术优先处理疝还是优先处理导致腹内压增高的情况，取决于腹外疝的状态
  - 腹外疝已经嵌顿/绞窄：急诊处理腹外疝
  - 未出现嵌顿/绞窄：择期处理腹外疝，先处理腹内压增高情况

（二）重要结构

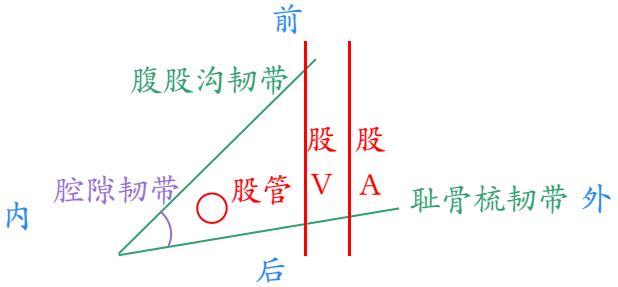
1.股管

①股管下口——卵圆窝：在腹股沟韧带下方

②股管上口——股环：前夫厚颜无耻，内侧的腔，往外面鼓



前	腹股沟韧带
后	耻骨梳/Cooper 韧带（腹股沟韧带的延伸结构）
内	腔隙韧带（腹股沟韧带的延伸结构）
外	股血管



2.腹股沟管

①长约 4–5cm

②内口/深环/腹环：体表投影在腹股沟韧带中点上方 2cm、腹壁下动脉外侧

③外口/浅环/皮下环

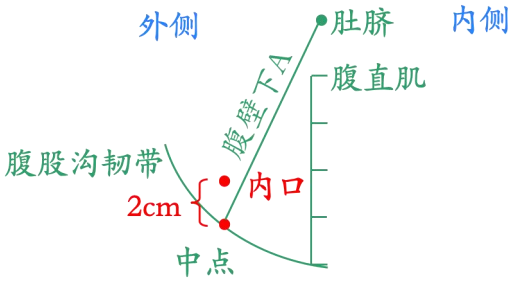
前	腹外斜肌腱膜（主要）、腹内斜肌
后	腹股沟镰（腹内斜肌和腹横肌腱膜构成的联合腱）、腹横筋膜、腹膜
上	腹内斜肌、腹横肌
下	腹股沟韧带（腹外斜肌腱膜卷曲形成）、腔隙韧带

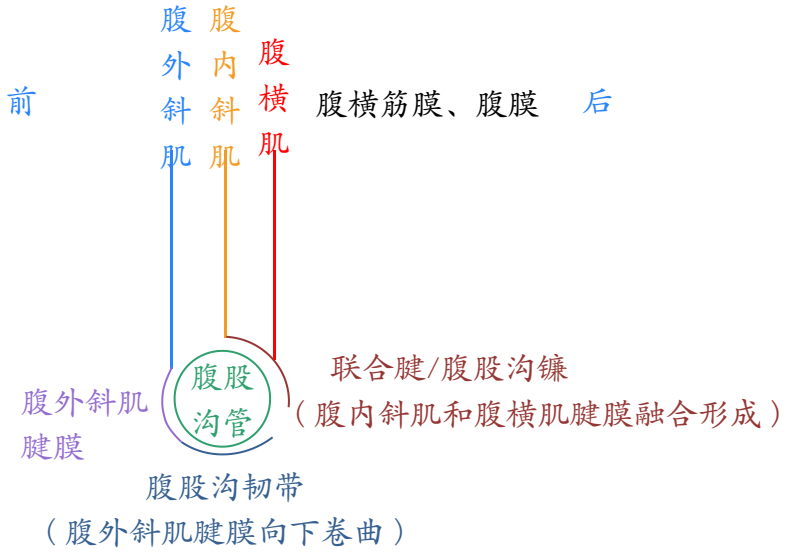
3.直疝三角/海氏三角/Hesselbach 三角

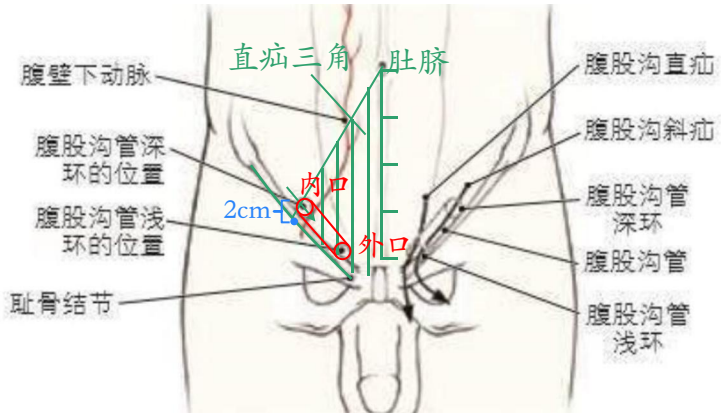
①腹壁下动脉

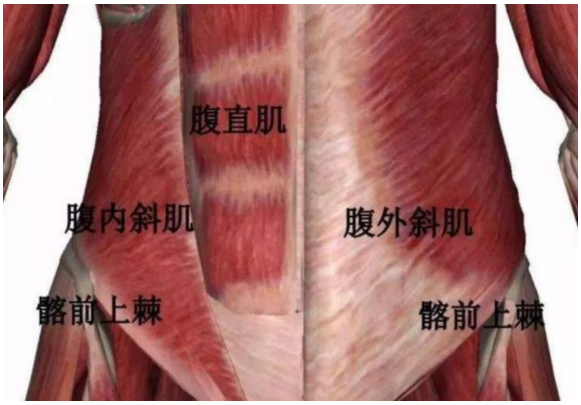
②腹直肌外缘

③腹股沟韧带









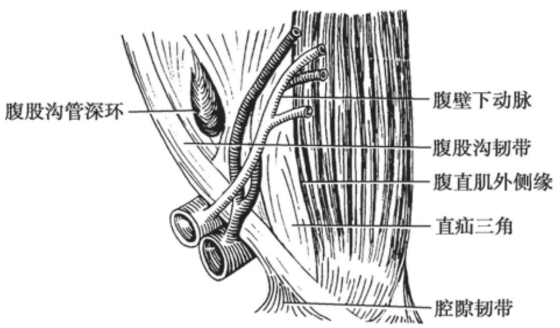
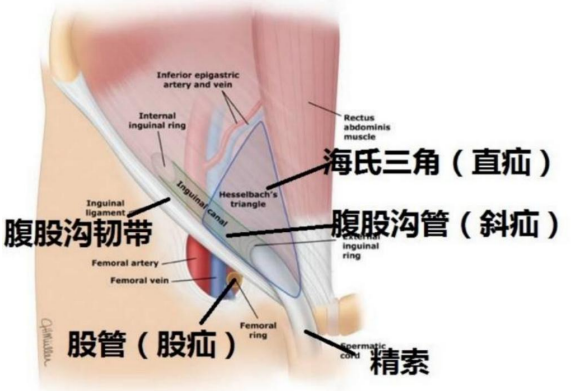
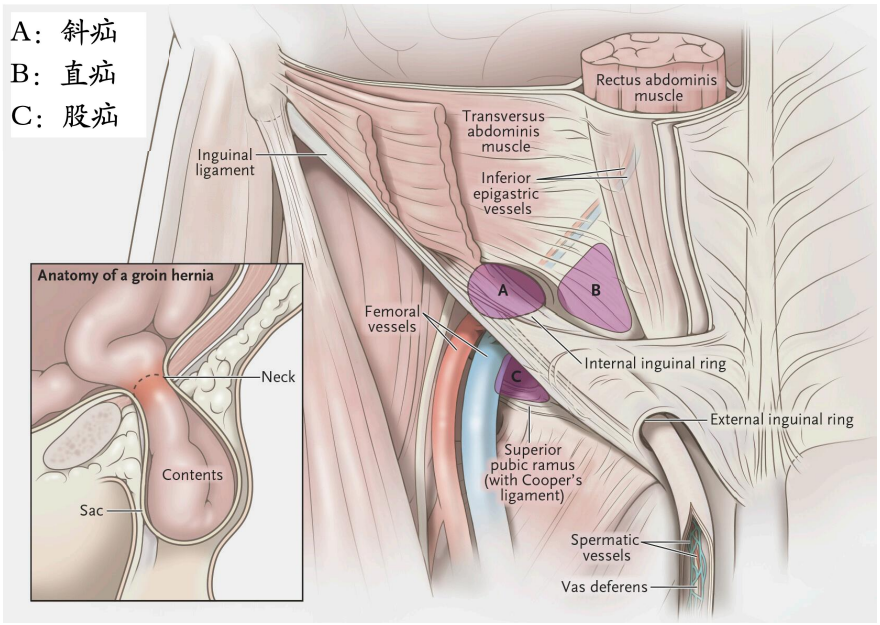
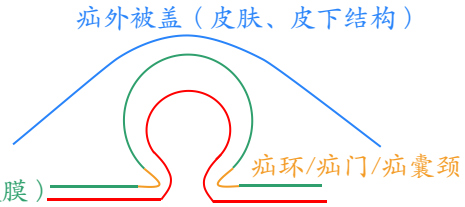


图 35-8　直疝三角(后面观)



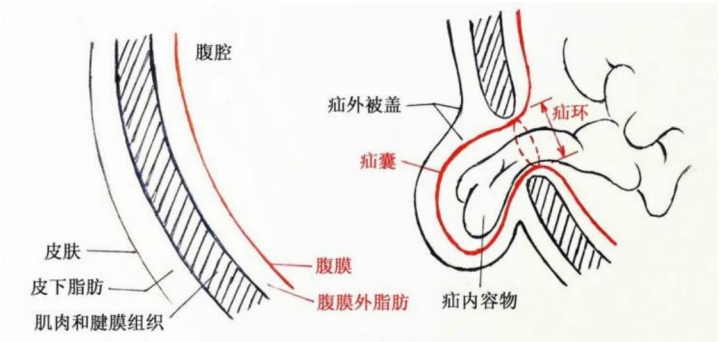


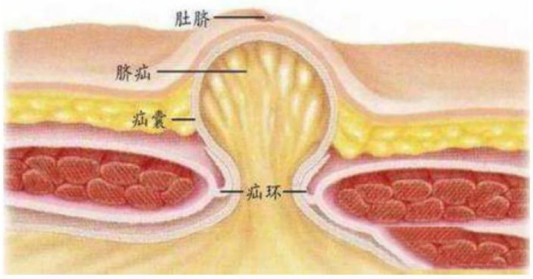


（三）疝的组成

疝内容物	如小肠、大网膜、脏层腹膜
疝囊	壁层腹膜
疝囊颈/疝环/疝门	疝囊狭小的部分，疝命名的主要依据
疝外被盖	疝囊外的筋膜、肌肉、脂肪、皮肤等腹膜外组织

「理顺知识点」
- 脏层腹膜的本质是消化道的浆膜层（消化道从内向外：粘膜层、粘膜下层、肌层、浆膜层（脏层腹膜））





疝的外形

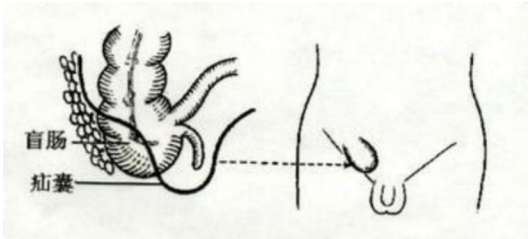
（四）疝的分类

1.易复疝

①疝内容物易回纳入腹腔（包块可消失）

②无疼痛

③最常见的疝内容物：小肠



「理顺知识点」
- 小肠占地空间最大→易复疝中，小肠是最常见的疝内容物

2.难复疝（粘住了）

①因粘连致疝内容物不能回纳或不能完全回纳入腹腔（包块不消失）

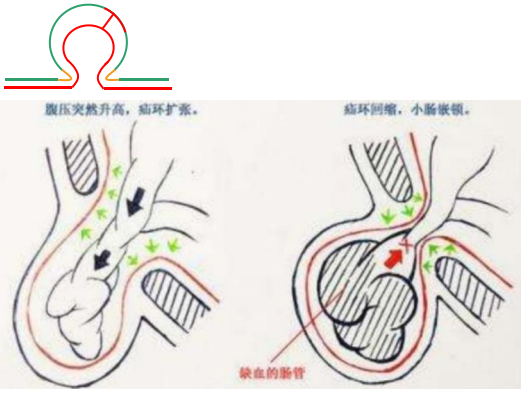
②不引起严重症状、无明显疼痛

③最常见的疝内容物：大网膜（小的难忘）

「理顺知识点」
- 疝内容物反复进出，与疝囊颈摩擦造成损伤→炎症→粘连→疝内容物无法回纳→包块不消失

特殊的难复疝——滑动性疝（滑啊滑滑成了疝囊的一部分）

疝内容物成为疝囊的一部分→切疝囊时避免误伤疝内容物
疝内容物以盲肠、阑尾、乙状结肠、膀胱多见，多见于右侧
常有消化不良、便秘



「理顺知识点」
- 盲肠活动度大，阑尾位置变化多，因此疝内容物以右侧更多见

3.嵌顿疝（卡住了）

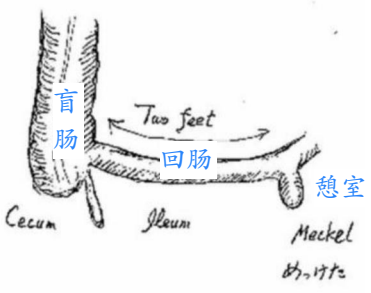
①疝内容物被卡住而不能回纳入腹腔（包块不消失、且逐渐增大）

②疼痛明显，可伴机械性肠梗阻（肠鸣音亢进）

③包括：

Richter/肠管壁疝（人民币）	嵌顿内容物仅为部分肠管壁，局部肿块不明显、多无肠梗阻、易误诊
Littre 疝	嵌顿内容物为小肠憩室如 Meckel 憩室 没扣—小气
Maydl/逆行性嵌顿疝	嵌顿肠管包括几个肠袢、呈 W 形。即使疝囊肠管存活也必须将腹腔内相关肠袢牵出检查以防隐匿在腹腔内的坏死肠袢被遗漏
Amyand 疝	嵌顿内容物为阑尾、常感染化脓（appendix）

「理顺知识点」
- 嵌顿疝卡住了→静脉回流受阻→疝内容物淤血、水肿→包块逐渐增大、疼痛明显
- 有时疝囊内的肠管正常，腹腔内的肠袢已坏死，此时若直接回纳会导致腹膜炎



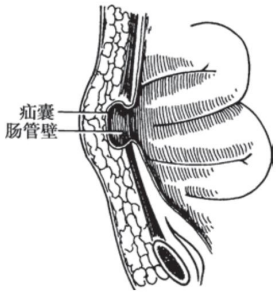


图 35-2　肠管壁疝

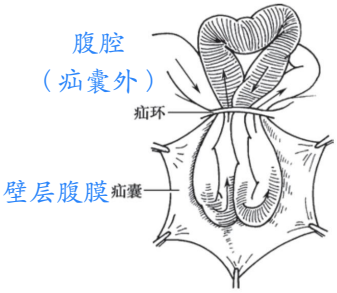
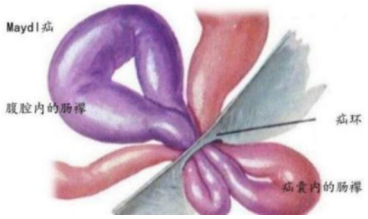


图 35-3　逆行性嵌顿疝



④嵌顿疝处理原则：多需急症手术复位；若全满足以下情况可急症手法复位——肠管无绞窄（无腹膜刺激征）、嵌顿＜4 小时、疝块和腹壁缺损大（没大事）

「理顺知识点」
- 嵌顿疝易绞窄，因此多需急症手术复位
- 疝块和腹壁缺损大→越不容易嵌顿（eg. 股管短小→股疝最易嵌顿）

4.绞窄疝（血运障碍）

①嵌顿疝易绞窄。但相对不易绞窄的嵌顿疝是 Richter/肠管壁疝、儿童嵌顿疝（儿童疝环较柔软）

②疼痛明显；但疼痛可暂时缓解、随后出现继发性腹膜炎（腹膜刺激征）、败血症

③绞窄疝急症手术：疝囊高位结扎、但不修补。若肠管坏死（肠管呈紫黑色、失去光泽和弹性、刺激后无蠕动、相应肠系膜内无动脉搏动、继发性腹膜炎、败血症）需切除坏死肠管

「理顺知识点」
- 绞窄疝是嵌顿疝的晚期
- 绞窄疝若发生肠道缺血坏死穿孔→局部压力骤减→绞窄疝疼痛暂时缓解→随后继发腹膜炎，甚至毒素大量吸收入血造成败血症
- 绞窄情况下局部非常脏，不宜采取修补，可择期进行修补

	包块消失？	疼痛	腹膜刺激征	
易复疝	√	×	×	
难复疝	×	×	×	滑疝
嵌顿疝	×，且增大	√	×	L A R M
绞窄疝	×	√	√	

5.切口疝：经腹直肌切口最常见；切口感染是最常见原因；多为难复疝；很少嵌顿（疝环大）；疝囊多不完整

「理顺知识点」
- 只有腹直肌的肌纤维走向是纵向的（其他如腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌肌纤维走向大部分偏横向），纵形切口会切断很多横行走向的纤维，形成薄弱区，进一步发生疝
- 切开→缺损大→疝环大→很少嵌顿
  切开→损伤→粘连大→多为难复疝
  切开→造成壁层腹膜不完整→疝囊多不完整

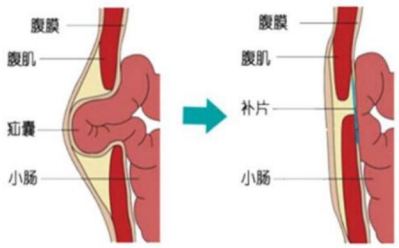
6.复发疝

真性复发疝	疝手术部位再次发生
遗留疝	手术时因疝较小被遗漏
新发疝	术后发生的疝与初次手术部位不同

（五）治疗

1.保守：＜1 岁、＜2 岁脐疝、不耐受手术（小脐没必要）

「理顺知识点」
- ＜1 岁，随着生长发育，疝自行消失，无需手术
- ＜2 岁脐疝，柔软不易嵌顿，保守处理即可
- 不耐受手术：不耐受手术的直疝、斜疝



2.单纯疝囊高位结扎：＞1 岁婴幼儿、绞窄疝（结扎大一窄）

3.单纯疝修补/无张力疝修补如 Rutkow 、Stoppa、Lichtenstein 法（亚狮龙/热死了）：疼痛轻、恢复快、低复发、最常用（但股疝最常用 McVay 法）。但材料为异物可引起感染

「理顺知识点」
- 单纯疝修补可不做高位结扎，传统意义上的高位结扎是将肌肉腱膜强行拉拢缝合（有张力），无张力疝修补利用补片完成，相当于高位结扎

4.疝囊高位结扎+修补

加强前壁	Ferguson 法（Front）
加强后壁	①Bassini 法：最常用（BBB 话最多） ②McVay 法：股疝、严重薄弱者，把腹内斜肌和联合腱缝合至耻骨梳韧带（摸屁股严重可耻） ③Shouldice 法：成人的大斜疝和直疝（应该大鞋子），重点修补腹横筋膜和内环（横 S 征） ④Halsted 法

「理顺知识点」
- 抓规律：一般缝合至腹股沟韧带；记特殊：McVay 法缝合至耻骨梳韧带

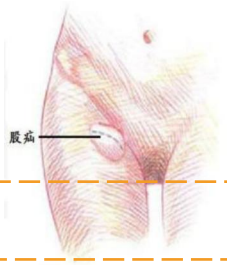
5.经腹腔镜疝修补：双侧腹股沟疝尤其是多次复发或隐匿性疝

二、股疝

内科 腹外疝2
00:50:18–00:56:37

①腹股沟韧带下方经股管向卵圆窝突出
②疝块小呈半球形，咳嗽冲击感不明显
③中老年肥胖女性多见
④最易嵌顿（不鸣则已一鸣惊人）

①嵌顿：急症手术复位
②绞窄：单纯疝囊高位结扎（不急症修补）
若肠管坏死→切除坏死肠管
③手术：
- 无张力疝修补 R S L
- 腹腔镜的疝修补
- McVay法



「理顺知识点」
- 股疝的疝囊颈较小→限制冲击传导→咳嗽冲击感不明显

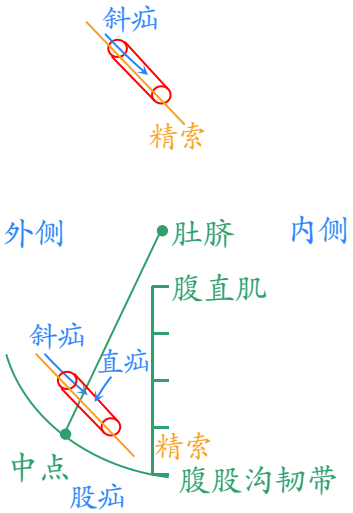
三、腹股沟疝

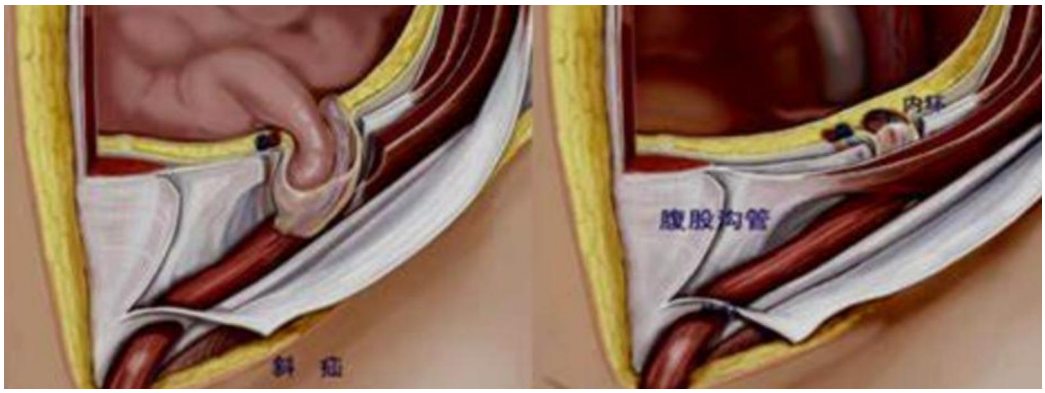
内科 腹外疝2
00:56:37–01:17:31

	斜疝	直疝
发病率	最常见	少见
机制	鞘突不闭锁或闭锁不全（右侧睾丸下降较晚→右侧多见又来晚了） 腹内斜肌等先天发育不全或后天腹壁薄弱	
好发	儿童、青年男性	老年男性
突出途径	经腹股沟管内口	经海氏/Hesselbach 三角
回纳疝块后压住内口	疝块不再突出（鉴别关键）	疝块仍可突出
疝块外形	椭圆或梨形、呈蒂柄状	半球形、基底较宽
进入阴囊/大阴唇	多√	几乎 ×
咳嗽冲击感	多√（小孩子咳嗽就很害怕）	几乎 ×
精索/子宫圆韧带	在疝囊后方 （小孩喜欢滑梯–精索是滑梯）	在疝囊前外方 （老直男喜欢顶–把精索顶出来）
疝囊颈在腹壁下动脉	外侧	内侧
嵌顿几率	多	少

「理顺知识点」

- 胚胎早期，睾丸位于腹膜后间隙，胎儿期睾丸沿腹股沟管逐渐下降至阴囊。推动相应腹膜下降，覆盖在睾丸表面的腹膜为鞘膜，睾丸表面的腹膜鞘膜的脏壁两层之间为鞘膜腔。正常情况下鞘膜腔闭合形成鞘膜突，若鞘膜突不闭合，导致小肠和液体可经未闭鞘膜突进入腹股沟区，形成斜疝和鞘膜积液
- 斜疝与睾丸下降过程相关，因此多见于儿童、青年男性





	斜疝	直疝	股疝
好发人群	儿童、青年男性	老年男性	中老年肥胖女性
包块与腹股沟韧带位置关系	上	上	下
疝外形	椭圆形，带蒂梨形	半球大	半球小
进入阴囊	√	多×	×
回纳疝块后压内口是否还会突出	不会	会	会
咳嗽冲击感	√	×	×
嵌顿几率	易	不易	最易
疝囊颈与腹壁下A关系	外	内	——
精索在疝囊的位置关系	后	前外	——

四、鉴别

内科 腹外疝2
01:17:31–01:22:17

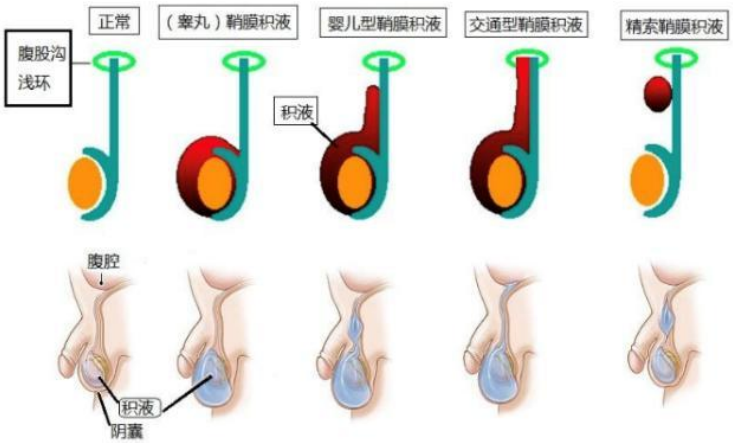
1. 隐睾（阴囊空虚感）

1 岁内	自行下降（等一等）
1 岁后	短期用 hCG（催一催–h 后c 催 g 睾）
2 岁前	睾丸固定术（最多等你到 2 岁）
睾丸萎缩+对侧睾丸正常	切除未降睾丸
双侧睾丸不能下降	睾丸自体移植术

2.鞘膜腔积液（透光试验阳性、无气液咕咕声）

	摸到睾丸?	平卧消失?
睾丸鞘膜积液	×	×
精索鞘膜积液	√	×
交通性鞘膜积液	√	可缩小消失

「理顺知识点」
- 透光试验和气液咕咕声：
  - 鞘膜腔积液：内容物仅为液体→透光试验阳性、无气液咕咕声
  - 腹股沟斜疝：内容物多为肠管，有气体、液体混合物→透光试验阴性、有气液咕咕声



真题解析 · 腹外疝

内科 腹外疝2
01:31:18–01:38:10

1. 2014N87 A　男性，75 岁。因腹股沟斜疝嵌顿 2 天急诊手术。术中见疝囊内有大团小肠，仍有活动，并有少量淡黄色渗出液，松解疝环，将小肠还纳腹腔并作疝修补术。术后第 2 天，患者自觉腹 痛较前加重，体温 38.8℃，腹部压痛、反跳痛、肌紧张，WBC 18×10^9/L，最可能的原因是
A.术中腹腔感染
B.术中损伤肠管
C.缺血性肠病发作
D.遗漏术中坏死肠袢

2.2015N77 A　以下腹部切口中，切口疝发生率最高的是
A.经腹直肌切口 纵形切口会切断很多横行走向的纤维，形成薄弱区，进一步发生疝
B.旁正中切口
C.沿肋缘斜切口
D.麦氏切口

3.2015N85 A　男性，23 岁。右腹股沟可复性包块 2 年。查体：肿块还纳后，压迫内环口肿物不再复出，无压痛。术后最有可能的发现是
A.直疝三角部位腹壁薄弱

　答案：1–3 D A B

B.疝囊颈位于腹壁下动脉外侧

C.盲肠组成疝囊壁的一部分 滑疝（难复疝）

D.疝内容物常为大网膜 难复疝

4.2017N61 A　以下选项中，最易发生嵌顿的腹外疝是 不鸣则已一鸣惊人

A.脐疝

B.股疝

C.腹股沟斜疝

D.腹股沟直疝

5.2019N63 A　男性，65 岁，右腹股沟包块 3 年，卧位可消失，12 小时前突然不能还纳，并出现右下腹痛。查体：T 38℃，P 100 次/分，右侧腹股沟 4×3cm 肿块，触痛明显，右下腹有压痛、肌紧张。正确的治疗方法是

A.切除坏死肠管，高位结扎疝囊 结扎大一窄

B.急行疝修补术 择期进行疝修补

C.切除坏死肠管后疝修补术

D.注射止痛剂后手法复位 全满足可急症手法复位 没大事

6. 2022N100−102 A　男，60 岁。因右腹股沟疝行手术治疗，术中见疝囊一部分由盲肠构成。

100.该患者的诊断是

A.Littre 疝

B.滑动疝

C.Richter 疝

D.逆行性嵌顿疝

101.处理疝囊过程中，最易误损伤的器官是

A.精索

B.膀胱

C.盲肠

D.股动脉

102.对该患者目前认为较合理的疝修补术式是 无张力修补 RSL 亚狮龙

A.Bassini 法

B.Halsted 法

C.McVay 法

D.Lichtenstein 法

　答案：4−6 B A BCD

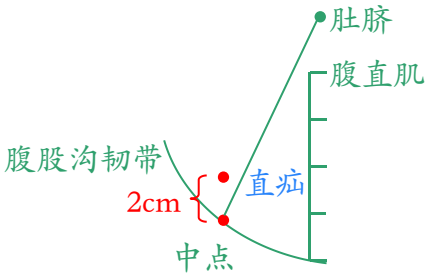
7.2023N63 A 关于腹股沟直疝的叙述，正确的是

A.疝内容物经腹壁下动脉外侧突出

B.多见于青年男性

C.压住深环站立时疝块出现

D. 易发生嵌顿和绞窄



8.2024N64 A 男性，65 岁。因右腹股沟疝行手术治疗，术中见疝囊的一部分由盲肠构成。应诊断为

A.肠管壁疝

B.滑动性疝 滑啊滑滑成了疝囊的一部分

C.逆行性嵌顿疝

D.腹内疝

　答案：7–8 C B